

Fecha Última Actualización: 29-03-2026 10:44:27

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Manuel Jorge Chávez Painén
Edad : 77a 4m 13d
Dirección : Estacion Angol

Rut : 6.105.788-9
Fecha Nacto: 16/11/1948
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A402000
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9647 0079

N° Epicrisis
476765

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalización

Fecha Ingreso : 27/03/2026 07:03

Días Estadía : 2

Unidad de Egreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Egreso : 29/03/2026 10:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Fístula gastrocutánea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente con antecedente de guillian barré, post debut requirió gastrostomía.
Actualmente comiendo por boca. Sin embargo, con persistencia de fístula gastrocutánea, pese a 2 intentos vía endoscópica.

Ingres a de forma electiva para resolución de fístula.

Se realiza el 27/03/26 cierre de fístula gastrocutánea + herniorrafia umbilical, sin incidentes.

Evoluciona con hemodinamia estable, afebril, escaso dolor. Buena tolerancia oral.
En condiciones de alta a domicilio y seguimiento ambulatorio.

Diagnóstico de Egreso

FISTULA DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Bien, escaso dolor, buena tolerancia oral.

Plan Post Alta

Reposo relativo, evitar reposo prolongado en cama. Deambular.
Régimen líquido por 5 días, luego progresar a papilla por 10 días, luego progresar a liviano según tolerancia.
Mantener heridas limpias y secas.
Uso de faja abdominal durante el día al menos 1 mes.

Fármacos:

Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 hrs por 7 días. Luego SOS dolor
Metamizol 300 mg, 1 comprimido cada 8 hrs por 3 días.
Omeprazol 20 mg, 2 comprimidos cada 12 hrs por 30 días.
Mantener fármacos de uso crónico en dosis habituales.

Control con Dra. Claudia Marín el jueves 2 de Abril a las 11 hrs en CDT pasillo 11. Atención por orden de llegada.

Fecha Epicrisis : 29/03/2026 10:44

Página 1 de 2

Acudir a urgencias en caso de fiebre, dolor intenso que no cede con analgesia, dificultad respiratoria, salida de pus por heridas, o en caso que estime necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Líquido

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Bec. Claudia Estefanía Marín Heis

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)